

1. У чоловіка на шкірі обличчя виявлено жовто-коричневу папулу розміром 5 мм. За результатами гістологічного дослідження утворення складається з круглястих клітин, що містять коричневий пігмент та ростуть окремими скупченнями в епідермісі вздовж дермо-епідермального з'єднання. На окремих ділянках спостерігається їх занурення в дерму у вигляді тяжів, які втрачають пігмент та стають менші за розміром. Вкажіть тип невусу.

- A. Пенетруючий
- B. Юнкціональний
- C. Диспластичний
- D. Інтрадермальний
- E. **Складний**

2. Пацієнта віком 64 роки шпиталізовано до лікарні зі скаргами на сильний головний біль, втрату орієнтації в просторі та сплутаність свідомості. З анамнезу відомо: періодично відмічаються епізоди підйому артеріального тиску. АТ - 210/120 мм рт. ст. Під час офтальмологічного огляду виявлено: крововиливи в сітківку ока. Аускультативно вислуховуються хрипи. Які морфологічні зміни судин нирки спостерігатимуться під час біопсії нирки?

- A. Гіаліновий артеріосклероз
- B. Медіальна кальцифікація артеріол
- C. **Фібриноїдний некроз артеріол**
- D. Кістозна медіальна дегенерація артеріол
- E. Некротизуюче запалення артеріол

3. Пацієнт віком 21 рік шпиталізований зі скаргами на продуктивний кашель, лихоманку та нічний піт. Під час рентгенографії грудної клітини визначено нечітко відмежовану ділянку ущільнення на периферії середньої частки правої легені та лімфаденопатію у середостінні. У культурі мокротиння знайдено кислотостійкі палички. Який результат гістологічного дослідження буде знайдено у біоптаті лімфатичного вузла цього пацієнта?

- A. Фолікулярна гіперплазія
- B. Абсцес
- C. Фіброзні зміни
- D. **Казеозні гранульоми**
- E. Неказеозні гранульоми

4. Під час аутопсії тіла чоловіка віком 60 років виявлено: склероз, кальциноз середньої оболонки стегнових артерій нижніх кінцівок, їх деформацію,

зморщеність, внутрішня поверхня нагадує поверхню трахеї, без виражених атеросклеротичних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Бергера-Вінівартера
- B. **Медіосклероз Менкеберга**
- C. Геморагічний васкуліт
- D. Вузликовий артеріїт
- E. Облітеруючий ендартеріїт

5. У дворічного хлопчика виявлено пухлину яєчка. Під час гістологічного дослідження пухлини виявлено: слабкоструктуровані ділянки, мікрокісти і сосочкові структури, які нагадують недорозвинені клубочки (тілця Шіллера-Дюваля). Укажіть гістологічний вид пухлини.

- A. Семінома
- B. Тератома
- C. Хоріокарцинома
- D. Ембріональний рак
- E. **Пухлина жовткового мішка**

6. Під час патологоанатомічного дослідження тіла чоловіка віком 50 років, який довгий час зловживав алкоголем, виявлено: печінка збільшена, охряно-жовтого кольору, консистенція її в'яла. Результати гістологічного дослідження: у гепатоцитах вакуолі заповнені рідиною, ядро зміщене до периферії. Проба Судан III позитивна. Яке ураження печінки виявлено?

- A. **Жирова дистрофія**
- B. Амілоїдоз
- C. Білкова дистрофія
- D. Цироз
- E. Вуглеводна дистрофія

7. У лабораторію для імуногістохімічного дослідження передано біоптат пухлини нирки, взятий у пацієнта віком 48 років. Вкажіть ціль проведення імуногістохімічного дослідження.

- A. Вивчення мікробіоти
- B. Аналіз рівня гормонів
- C. Визначення токсинів
- D. Вивчення ультраструктур
- E. **Встановлення гістогенезу**

8. Під час розтину тіла новонародженого, мати якого під час вагітності хворіла на токсоплазмоз, виявлено: наявність множинних дифузних запальних інфільтратів у головному мозку, печінці та

інших паренхіматозних органах. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфекційна фетопатія
- B. Діабетична фетопатія
- C. -
- D. Фетальний муковісцидоз
- E. Фіброеластоз

9. У пацієнтки віком 52 роки на введення антибіотика раптово розвинулася небажана реакція зі змінами артеріального тиску крові спочатку до 100/60 мм рт. ст., за кілька годин до 80/40 мм рт. ст., далі - 40/20 мм рт. ст. і при падінні артеріального тиску до нуля жінка померла. Мікроскопічне дослідження яких судин необхідно провести в першу чергу для встановлення патологоанатомічного діагнозу?

- A. Судин мікроциркуляторного русла
- B. Порожнистих вен та судин, які в них впадають
- C. Аорти та артерій, які від неї відходять
- D. Коронарних артерій серця
- E. Церебральних артерій

10. У пацієнта віком 73 роки на вушній раковині спостерігається вузлувате гіперкератозне утворення. Під час гістологічного дослідження виявлено: нерівномірне розростання атипових клітин плоского епітелію у вигляді часточок з інтенсивною кератинізацією та інвазією їх у дерму. Який найімовірніший діагноз?

- A. Кератоакантома
- B. Базальноклітинна карцинома
- C. Актинічний кератоз
- D. Аденокарцинома
- E. Плоскоклітинна карцинома

11. Під час розтину тіла жінки віком 50 років, яка хворіла на рак шлунка, виявлено: яєчники різко збільшені в розмірах, щільні, білясті. Який шлях метастазування спостерігається в цьому разі?

- A. Гематогенний
- B. Імплантаційний
- C. Контактний
- D. Лімфогенний ортоградний
- E. Лімфогенний ретроградний

12. Під час патологоанатомічного розтину тіла однорічної дитини, яка померла від двобічної гнійної пневмонії, виявлено ознаки відставання у фізичному розвитку, незарощення тім'ячка, краніотабес, деформація грудної клітки, потовщення ребер на межі кісткової та хрящової

тканини, незначне збільшення селезінки та лімфатичних вузлів. Якому діагнозу відповідають описані морфологічні зміни?

- A. Рахіт
- B. Остеодисплазія
- C. Флюороз
- D. Хвороба Аддісона
- E. Остеодистрофія

13. Під час розтину тіла пацієнтки спостерігається збільшений яєчник до 8 см в діаметрі, коричневого кольору, на поперечному розрізі тканина згладжена, присутні елементи плодового яйця темно-сірого кольору. Який патологічний стан розвинувся в яєчнику?

- A. Яєчникова вагітність
- B. Пухлина Бреннера
- C. Синдром Штейна-Левенталя
- D. Хоріокарцинома
- E. Фолікулярні кісти

14. Жінка померла від внутрішньої кровотечі. Під час гістологічного дослідження виявлено децидуальні клітини та ворсини хоріона в слизовій оболонці маткової туби. Які зміни в матковій трубці спричинили її руйнування та крововилив?

- A. -
- B. Сальпінгоофорит
- C. Трофобластне вростання
- D. Залозиста гіперплазія слизової оболонки
- E. Гострий сальпінгіт

15. Чоловік, який протягом останніх 45 років кував одну пачку сигарет на день, помер від гострої дихальної недостатності. Протягом останнього місяця скаржився на кашель із кровохарканням та задишкою, що наростала. Під час гістологічного дослідження легеневої тканини виявлено: ріст великих клітин із значно збільшеними ядрами з високим ступенем ядерного плеоморфізму, формуванням ядерця та вираженими ознаками мітотичної активності. Вищезазначені клітини формують гнізда, трабекули, солідні ділянки росту, вогнищево відзначається гістологічний паттерн 'палісаду'. Ознак формування залоз клітинами не виявлено. Під час додаткового імуногістохімічного забарвлення клітини позитивно реагують на антитіла до синаптофізину та хромограніну, реакція з антитілами до p40 негативна. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- A. Аденокарциноми
- B. **Великоклітинної карциноми**
- C. Дрібноклітинної карциноми
- D. Плоскоклітинного раку
- E. Пневмонії

16. Під час дослідження біоптату нирки п'ятирічного хлопчика, який хворіє на нефротичний синдром, виявлено, що епітеліальні клітини звивистих каналців збільшені у розмірах, а в їх цитоплазмі містяться дрібні еозинофільні гранули, які при електронномікроскопічному аналізі ідентифіковано як фаголізосоми. Яка речовина накопичена у клітинах?

- A. Урати
- B. Цитокератин
- C. **Білок**
- D. Глюкоза
- E. Тригліцериди

17. У пацієнта виявлено збільшення надключичного лімфатичного вузла, під час гістологічного дослідження якого спостерігається тотальне порушення його нормальної архітектури. Відзначається заміщення тканини лімфовузла дифузним ростом великих атипових лімфоїдних клітин із вузьким обідком блідої цитоплазми, великим везикулярним гіперхромним ядром та помітними ядерцями, присутня різко виражена проліферативна активність. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Мантійноклітинна лімфома
- B. **Дифузна В-великоклітинна лімфома**
- C. Хвороба Годжкіна
- D. Мала лімфоцитарна лімфома
- E. Хронічний лімфаденіт

18. Пацієнтка віком 45 років звернулася до лікаря зі скаргами на періодичну вагінальну кровотечу та біль унизу живота. ХГЛ негативний. З анамнезу відомо: має трьох дітей, остання дитина народилася 10 років тому. Після клінічного обстеження виконано гістеректомію. Макроскопічно спостерігається: тіло матки дифузно збільшене, сферичної форми, стінка потовщена, ендометрій має нормальний вигляд. Під час гістологічного дослідження в міометрії між пучками м'язових волокон визначаються множинні осередки ендометріальної строми та залоз, ендометрій фази проліферації. Якому діагнозу відповідають результати морфологічного дослідження?

- A. **Мультифокальний аденоміоз**

- B. Ендометріальна стромальна саркома
- C. Вузлової лейоміоми
- D. Карцинома ендометрія
- E. Гестаційна трофобластична хвороба

19. У молодій жінки через півроку після абортів виникли метрорагії. Після діагностичного вишкрібання крововиливи не припинились. Під час гістологічного дослідження виявлено клітини цитотрофобласта та багатоядерного синцитіотрофобласта. Які тканинні елементи стали джерелом пухлини?

- A. Міометрій
- B. Ендометрій
- C. **Ворсини хоріона**
- D. Тканини яєчника
- E. Слизова оболонка цервікального каналу

20. Дев'ятирічний хлопчик помер від септицемії. Під час бактеріологічного дослідження крові та мокротиння виявлено: ріст культури *Pseudomonas aeruginosa*. З анамнезу відомо: були жовтяниця, діарея, об'ємні виділення з неприємним запахом протягом останніх 5 років, катаракта. Результати розтину включали некротизуючу пневмонію, закорковування слизов панкреатичних проток з екзокринною атрофією підшлункової залози, стеатогепатоз з трансформацією у цироз. Вкажіть імовірну причину смерті дитини.

- A. **Дефіцит галактозо-1-фосфатуридилтрансферази**
- B. -
- C. Порушення транспорту хлорид-іонів епітеліальними клітинами
- D. Дефіцит фенілаланінгідроксилази
- E. Загальний варіабельний імунodefіцит

21. У пацієнтки віком 24 роки в лікарні гостро розвинулася масивна шлункова кровотеча, різке падіння артеріального тиску, олігурія, а згодом й анурія. Жінка померла. Під час розтину виявлено: чисельні петехії в різних органах, в шлунку кілька десятків гострих ерозій та чорних плоских цяток різних розмірів у всіх відділах шлунку. Гістологічно спостерігається: в нирках виявлений гострий папілярний некроз. Передозування якої лікарської речовини (кислоти) повинен запідозрити патологоанатом на основі виявлених морфологічних даних та анамнезу?

- A. **Ацетилсаліцилової**
- B. Бурштинової

- С. Аскорбінової
- Д. Нікотинової
- Е. Амінокапронової

22. У чоловіка віком 84 роки протягом останніх місяців поступово з'явилися такі ознаки: порушення пам'яті, мовлення, знизилася здатність до просторової та часової орієнтації, втрачені навички читання та писання, зросла дратівливість. Пацієнт помер при явищах наростаючого виснаження. Під час розтину виявлено: зменшення маси головного мозку до 904 г, симетрична атрофія звивин і розширення борозн, розширення шлуночків мозку. Під час світлової мікроскопії виявлено: сенільні амілоїдні бляшки (переважно в гіпокампі), тільця Хірано у вигляді еозинофільних включень. Під час електронної мікроскопії виявлено: нейрофібрилярні сплетення в цитоплазмі нейронів. Клітинна атипія гліальних клітин не спостерігається. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- А. Хвороби Піка
- В. Гліобластоми
- С. **Хвороби Альцгеймера**
- Д. Хвороби Кройтцфельда-Якоба
- Е. Епендимомии

23. У чоловіка віком 38 років з'явився кашель та задишка. Лікар інтерпретував рентгенограму органів грудної клітки як правобічну нижньодолеву пневмонію. Об'ємних утворень не виявлено. Лікується антибіотиками, але симптоми не зникають. Під час повторного візиту площа консолідації виглядає збільшеною. Проведена бронхоскопія. Бронхіальних утворень не виявлено. Взято трансbronхіальну біопсію в зоні еритеми слизової оболонки. Під час гістологічного дослідження виявлено добре диференційовані клітини циліндричного епітелію, що продукують слиз, інфільтрують стінки альвеол і поширюються від альвеоли до альвеоли через пори Кона. Для якого виду карциноми характерні такі гістологічні особливості?

- А. **Бронхіолоальвеолярного/вистеляючого типу аденокарциноми**
- В. Гігантоклітинної
- С. Дрібноклітинної
- Д. Плоскоклітинної
- Е. Медулярної

24. Чоловік віком 53 роки скаржився на раптовий колючий біль, що з'явився в передній частині грудної клітки та іррадіював у міжлопаткову ділянку. Стан пацієнта стрімко погіршувався, він втратив свідомість, попри проведені реанімаційні заходи пацієнт помер. З анамнезу відомо, що чоловік тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу. Під час розтину виявлено: кров у перикардальній порожнині. Які мікроскопічні зміни стінки аорти будуть виявлені під час гістологічного дослідження?

- А. **Кістозна дегенерація медії**
- В. Трансмуральне некротизуюче запалення
- С. Гігантські клітини та фіброз
- Д. Пінисті макрофаги в інтимі
- Е. Еозинофільний інфільтрат у медії

25. На гістологічне дослідження патологоанатому доставлений матеріал у вигляді комплексу великої кількості пухирів діаметром 1-10 мм, що зібраний від жінки з перериванням вагітності. Гістологічно залишків плідного яйця не виявлено, пухирі були сильно збільшеними в розмірах хоріальними ворсинками з ознаками помітного набряку. Епітелій ворсинок включав цитотрофобласт та синцитіотрофобласт звичайної будови. Вкажіть гістологічний діагноз.

- А. Трофобластична пухлина плаценти
- В. Частковий пухирний занесок
- С. Хоріонкарцинома
- Д. **Повний пухирний занесок**
- Е. Переривання звичайної вагітності

26. Проведено патологоанатомічний розтин тіла померлого пацієнта віком 54 роки, який був шпиталізований за добу до смерті зі скаргами на гострий біль в животі, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість, епізоди блювання із забарвленням блювотних мас кольором 'кавової гущі'. Визначте основне захворювання за результатами розтину.

- А. **Перфоративна виразка шлунку**
- В. Загальний гнійний перитоніт
- С. Абсцес печінки
- Д. Абсцес селезінки
- Е. Венозне повнокрів'я нирок

27. У пацієнтки віком 72 роки раптово з'явилася виражена слабкість у правій руці, а згодом вона зовсім перестала її відчувати. Пацієнтка була шпиталізована до лікарні, де померла через тиждень внаслідок

розвитку гострого інфаркту міокарда. Вкажіть, які морфологічні зміни будуть виявлені в головному мозку померлої.

- A. Пінисті гістіоцити в лівій півкулі
- B. Гліофіброз у лівій півкулі
- C. Червоні нейрони в лівій півкулі
- D. Набряк нервової тканини в правій півкулі
- E. Пінисті макрофаги в правій півкулі

28. Під час гістологічного дослідження тканини щитоподібної залози виявлено пухлинні клітини, що формують однакові за розмірами мономорфні фолікули, що містять колоїд. Пухлина відмежована від нормальної тканини добре сформованою інтактною капсулою. Для якого захворювання щитоподібної залози характерні виявлені морфологічні зміни?

- A. Фолікулярної карциноми
- B. Фолікулярної аденоми
- C. Медулярної карциноми
- D. Папілярної карциноми
- E. Папілярної аденоми

29. У пацієнта віком 43 роки упродовж 6-ти тижнів спостерігається нудота та блювання. Також у нього спостерігався епізод гематемезису. Під час ендоскопічного дослідження в антральному відділі шлунку виявлено: ураження діаметром 1,5 см із втратою епітеліальної поверхні. Для якого з нижченаведених патологічних процесів ці ознаки найхарактерніші?

- A. Гангрени
- B. Поліпа
- C. Дисплазії
- D. Виразки
- E. Флегмони

30. Під час гістологічного дослідження новоутворення шкіри пацієнта виявлено: наявність синьо-фіолетовий вузол із великою кількістю мітозів у клітинах, осередками крововиливів та некрозів. Який найімовірніший діагноз?

- A. -
- B. Меланома
- C. Блакитний невус
- D. Фіброма
- E. Невус

31. У пацієнта з гострим респіраторним дистрес-синдромом виявлено характерну мікроскопічну ознаку. Укажіть характерну мікроскопічну ознаку, що можна виявити

під час гістологічного дослідження секційного матеріалу легеневої тканини в цьому разі.

- A. Гіалінові мембрани
- B. Атипові клітини
- C. Мальформація судин
- D. Інфільтрація лімфоцитами
- E. Інфільтрація еозинофілами

32. Під час фіброгастродуоденоскопії виявлено: виражена гіпертрофія шлункових складок, що нагадують звивини головного мозку з різким переходом на нормальну слизову. Під час мікроскопічного дослідження біоптатів зі слизової оболонки шлунку виявлено: виражена фовеолярна гіперплазія, звивисті та кістозно розширені залози, набряк і помірно виражена запальна інфільтрація власної пластинки, збільшення кількості внутрішньоепітеліальних лімфоцитів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Аденокарцинома
- B. Гелікобактерпілорі-асоційований гастрит
- C. Виразка шлунку
- D. Хвороба Менетріє
- E. Хронічний атрофічний гастрит

33. Пацієнтові віком 50 років виконано пункційну біопсію збільшеної простати (кількох фрагментів із різних відділів). Під час мікроскопічного дослідження перехідної зони виявлено: збільшення числа парауретральних залоз та об'єму фібромускулярної стромы. В ацинусах подекуди сосочкові та криброзні структури, окремі кісти. Клітинного атипізму епітелію чи стромальних клітин не відмічено. Запальний процес відсутній. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Хронічний бактеріальний простатит
- B. Рак простати
- C. Гострий бактеріальний простатит
- D. Саркома простати
- E. Доброякісна гіперплазія простати

34. Під час розтину тіла чоловіка, який помер від серцево-судинної недостатності, що прогресувала, в просвіті правої легеневої артерії виявлено темно-червоні маси із гофрованою поверхнею, що обтурують просвіт артерії. Для якого патологічного процесу характерні ці морфологічні зміни?

- A. Тромбоемболії легеневої артерії
- B. Місцевого венозного повнокрів'я

- С. Кровотечі
- Д. Загального венозного повнокрів'я
- Е. Тромбоемболії судин великого кола кровообігу

35. Під час гістологічного дослідження збільшеного шийного лімфовузла у жінки з регіонарною лімфаденопатією спостерігаються зірчасті некротичні гранульоми неправильної форми. З анамнезу відомий контакт з кішками 2 тижні тому. Який тип захворювання відповідає описаній гістологічній картині?

- А. Лімфома Годжкіна
- В. Лімфоплазмочитарна лімфома
- С. Лімфома із клітин мантиї
- Д. Фолікулярна лімфома
- Е. Лімфаденіт

36. Жінку віком 23 роки у терміні вагітності 15 тижнів шпиталізовано з матковою кровотечею та виділеннями невеликої кількості водянистої рідини та тканини. За результатами обстеження виявлено: матка не відповідає терміну вагітності, порожнина матки заповнена кістозними, безсудинними, подібними до грона винограду структурами, які не пронизують стінку матки. Тканини плода не візуалізуються. Який найімовірніший діагноз?

- А. Інвазивний пухирний занесок
- В. Трофобластна пухлина плаценти
- С. Частковий пухирний занесок
- Д. Повний пухирний занесок
- Е. Хоріокарцинома

37. Пацієнтові в плановому порядку проведено адреналектомію через пухлинне утворення. Лабораторно у плазмі та сечі пацієнта відзначається підвищення рівня метанефринів. Під час огляду наднирникової залози виявлено: утворення жовтого кольору з вогнищами некрозів та крововиливів. Під час гістологічного дослідження спостерігається: ріст клітин з рясною базофільною цитоплазмою і секреторними гранулами. Клітини розташовані у вигляді гнізд, широких трабекул, розділених тонкостінними синусоїдами, які обмежені фіброеваскулярною стромою. Який найімовірніший діагноз?

- А. Феохромоцитома
- В. Карцинома
- С. -
- Д. Хвороба Аддісона
- Е. Аденома

38. Під час розтину тіла чоловіка віком 40 років виявлено: велика кількість розсіяних пляшок сірого кольору в білій речовині головного мозку. Мікроскопічно: дрібні периваскулярні осередки демієлінізації, що зливаються, проліферати клітин мікроглії. Який найімовірніший діагноз?

- А. -
- В. Хвороба Піка
- С. Боковий аміотрофічний склероз
- Д. Хвороба Альцгеймера
- Е. Розсіяний склероз

39. Пацієнт віком 32 роки з множинними переломами обох нижніх кінцівок, які він отримав у ДТП, перебував у стаціонарі травматологічного відділення упродовж 2-х місяців. В анамнезі: вада серця. Після емоційної розмови пацієнт зненацька став дезорієнтованим, втратив свідомість. Через 3 дні він помер. На аутопсії внутрішні органи без особливих морфологічних змін: у правій середньомозковій артерії визначається ембол, тканина головного мозку у правій тім'яній області вогнищево має безструктурний вигляд сірого кольору з дрібними точковими крововиливами. Який вид емболії розвинувся у пацієнта?

- А. Парадоксальна жирова емболія
- В. Ортоградна жирова емболія
- С. Ортоградна тромбоемболія
- Д. Ретроградна тромбоемболія
- Е. Парадоксальна тромбоемболія

40. Під час аутопсії пацієнта віком 30 років із ВІЛ-інфекцією виявлено генералізований гістоплазмоз, який спричинив смерть пацієнта. Яким захворюванням є гістоплазмоз у патологоанатомічному діагнозі у цьому випадку?

- А. Вторинний
- В. Конкуруючим
- С. Фоновим
- Д. Супутнім
- Е. Поєднаним

41. У чоловіка віком 64 роки протягом останніх трьох років спостерігалися прогресивне погіршення пам'яті та порушення мови, також змінилися соціальні навички. Комп'ютерна томографія голови не виявляла анатомічних відхилень. Пацієнт помер внаслідок розвитку двобічної пневмонії. На розтині виявлено атрофію лобових і скроневих часток головного мозку з розширенням звивин, гідроцефалію. Які з нижчеперерахованих гістологічних ознак

буде виявлено під час мікроскопічного дослідження головного мозку?

- A. Мікрогліальні вузлики
- B. *Coccidia amyloacea* в неокортексі
- C. Тільця Леві в чорній субстанції
- D. Скупчення пінистих макрофагів
- E. **Нейрофібрилярні сплетіння в корі**

42. Пацієнт віком 28 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на мігруючий біль у суглобах та періодичну діарею. Була проведена колоноскопія, отримана біопсія. Під час мікроскопічного дослідження виявлено: змінену архітектуру слизової оболонки, криптити, трансмуральні агрегати лімфоцитів і поодинокі вузлуваті скупчення епітеліоїдних клітин із домішкою поодиноких велетенських гігантських клітин, переважно за типом Лангханса, які оточені кільцем лімфоцитів. Якому діагнозу відповідають результати гістологічного дослідження?

- A. **Хвороба Крона**
- B. Ішемічний коліт
- C. Туберкульозний коліт
- D. Неспецифічний виразковий коліт
- E. Інфекційний неспецифічний коліт

43. Під час фіброгастродуоденоскопії пацієнтові, який скаржиться на тупий біль у підребер'ї та нудоту, взято біопсію. За результатами гістологічного дослідження спостерігається помітне стоншення слизової оболонки дна та тіла шлунку, що інфільтрована лімфоцитами, плазматичними клітинами, часткове згладження губоподібних складок, зменшення кількості та розширення просвіту залоз, повна відсутність парієтальних клітин, розростання сполучної тканини, дисплазія поверхневого епітелію, наявність келихоподібних клітин та клітин Панета. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний бактеріальний атрофічний гастрит
- B. Реактивна (хімічна) гастропатія
- C. Аденокарцинома
- D. **Хронічний аутоімунний атрофічний гастрит**
- E. Виразка шлунку

44. У пацієнта віком 84 роки протягом останніх 2-х діб спостерігається підвищення температури тіла та кашель. Під час бактеріоскопічного дослідження мокротиння виявлено золотистий стафілокок. Пацієнт отримує курс

антибіотикотерапії. За два тижні у нього відсутній продуктивний кашель, але утримується гарячка. Під час рентгенографії грудної клітки виявлено: округла щільність 3 см у правій нижній частці, розріджений уміст якої утворює центральний повітряно-рідинний рівень. Навколишніх інфільтратів немає. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. **Абсцес**
- B. Карцинома
- C. Пневмосклероз
- D. Гангрена
- E. Каверна

45. Під час гістологічного дослідження біоптату плеври виявлено: ділянку центрального некрозу, оточену численними багатоядерними гігантськими клітинами, епітеліоїдними клітинами та лімфоцитами. Для якого виду запалення характерна ця морфологічна картина?

- A. Серозного
- B. Катарального
- C. Фібринозного
- D. **Гранульоматозного**
- E. Гнійного

46. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий малопродуктивний кашель, виражену задишку та хрипи. З анамнезу відомо, що в минулому у нього було кілька подібних нападів, після яких були відсутні симптоми розладів дихання. Що з нижче перерахованого виявить гістологічне дослідження легенів?

- A. Кристали холестерину
- B. Астероїдні тільця
- C. Тільця Шаумана
- D. **Кристали Шарко-Лейдена**
- E. Гранульоматозне запалення

47. Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років спостерігається: желеподібний згорткок темно-червоного кольору масою 50 г у порожнині перикарду, на задній стінці лівого шлуночка є наскрізний щілиноподібний розрив. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Гемотампонада**
- B. Тромбоемболія легеневої артерії
- C. Атеросклеротична хвороба серця
- D. Аневризма аорти
- E. -

48. Під час гістологічного дослідження тканини печінки спостерігається вузол із зонами некрозу та крововиливами в центрі. Клітини, що формують вузол, виявляють виражені цитологічні ознаки атипії - відзначається варіабельність за розміром клітин, ядра плеоморфні; клітини мають густу еозинофільну цитоплазму, формують багаторядні трабекули та тяжі, між якими розміщені синусоїди, присутні тільця Меллорі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Холангіокарцинома
- B. -
- C. Гепатоцелюлярна аденома
- D. Гепатоцелюлярна карцинома
- E. Гепатобластома

49. У жінки віком 38 років у правій грудній залозі в глибині пальпуються кілька вузлів високої щільності, болючих на дотик. Лімфатичні вузли без особливостей. З вузлів правої грудної залози взято чотири трепанбіоптати. Під час мікроскопії усіх біоптатів виявлено: виражений фіброз строми грудної залози й утворення круглястих кіст різних розмірів, рівномірно вистелених залозистим епітелієм. Клітинної атипії в епітелії чи строми не виявлено. Для якого захворювання грудної залози це характерно?

- A. Інтраканалікулярної фіброаденоми
- B. Периканалікулярної фіброаденоми
- C. Протокової карциноми
- D. Фіброкістозної хвороби
- E. Карциноми Педжета

50. Пацієнт віком 79 років звернувся до лікаря зі скаргами на здуття живота, закреп, що триває 8 днів. Під час обстеження в прямій кишці виявлено: кільцеподібне ураження, яке критично звужує її просвіт. Пацієнту було проведене оперативне втручання. Під час дослідження операційного матеріалу макроскопічно в прямій кишці визначається виразка розміром 5,5 см з некротичними масами, стінки виразки потовщені, щільні, без чіткої межі. У сім'ї пацієнта ураження шлунково-кишкового тракту не спостерігалось. Який із нижченаведених патологічних станів спричинив розвиток захворювання?

- A. Ворсинчаста аденома
- B. Атипова лейоміома
- C. Гіперпластичний поліп
- D. Поліп Пейтца-Єгерса
- E. Хронічний коліт

51. Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років виявлено: гіперемія судин мозку, набухання та набряк тканин, дрібні крововиливи на розрізі. Мікроскопічно: фібрилярний гліоз, демієлінізація. Відомо, що напередодні відвідував ліс. Який найімовірніший діагноз?

- A. Субарахноїдальний крововилив
- B. Кліщовий енцефаліт
- C. Менінгіт
- D. Геморагічний інсульт
- E. -

52. На шкірі шиї пацієнтки віком 28 років виявлено ворсинчасте утворення розміром 0,5x0,5x0,7 см, яке нагадувало цвітну капусту. Проведено біопсію утворення, гістологічно виявлено: папілярні фіброваскулярні вирости строми, вкриті багат шаровим плоским зроговілим епітелієм. Клітини епітелію та строми без ознак атипії. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Фіброма
- B. Карцинома
- C. Папілома
- D. Фібросаркома
- E. Базаліома

53. Під час ультразвуграфічного дослідження матки в пацієнтки під ендометрієм виявлено чітко відмежований вузол круглястої форми діаметром 4,5 см. Під час оперативного втручання гінеколог повністю видалив вузол і направив його на гістопатологічне дослідження. Під час мікроскопії вузла виявлено: різнонаправлені пучки лейоміоцитів без атипії, окремі осередки фіброзу, дрібні кальцифікати. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Лейоміома
- B. Фібросаркома
- C. Лейоміосаркома
- D. Аденоміоз
- E. Ендометріальна карцинома

54. Під час біопсії утворення неправильної форми (розміри 3x5x6 см) підшкірної основи стегна жінки старшого віку виявлені різноманітні клітини з прозорими краплями різних розмірів, помітний клітинний поліморфізм із різними розмірами й формою клітин та їхніх ядер з численними ядерцями, патологічні фігури мітозу. До якого класу пухлин належить виявлена неоплазія?

- A. Карциноми

- В. Тератоми
- С. Аденоми
- Д. Саркоми
- Е. Меланоми

55. Жінка віком 75 років скаржиться на біль у ділянці лівого стегна, який посилюється під час руху. Проведено ендопротезування лівого кульшового суглоба. Під час гістологічного дослідження хірургічного зразка спостерігається: руйнування хрящової тканини суглоба, ебурнеція кістки, субхондральні кісти, остеопіти по краях суглобової поверхні. Який найімовірніший діагноз?

- А. Остеобластома
- В. Саркома Юінга
- С. Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина
- Д. Остеоартрит
- Е. Ревматоїдний артрит

56. У пацієнта віком 62 роки наступила раптова коронарна смерть. Під час патологоанатомічного розтину тіла були виявлені: системний гіаліноз артеріол і дрібних гілок артерій, гіпертрофія міокарда (товщина стінки лівого шлуночка - 1,7 см), системний атеросклероз. В анамнезі хронічна виразка шлунку. Яке фонове захворювання повинен встановити лікар-патологоанатом у структурі патологоанатомічного діагнозу?

- А. Гіпертонічна хвороба
- В. Хронічна виразка шлунку
- С. Системний гіаліноз
- Д. Системний атеросклероз
- Е. Гіпертрофія міокарда

57. У пацієнта віком 64 роки з хронічною недостатністю серця виявлено застій крові в різних органах великого кола кровообігу. У серозних оболонках при цьому спостерігаються множинні дрібні цяткові крововиливи (діаметром близько 1-2 мм). Мікроскопічно визначено, що вони локалізуються периваскулярно. Вкажіть вид крововиливів.

- А. Петехії
- В. -
- С. Гематоми
- Д. Екхімози
- Е. Геморагії

58. У пацієнтки віком 32 роки на 28-й день менструального циклу спостерігається менструальна кровотеча, що триває декілька днів. Регулярні менструальні

цикли у жінки тривають протягом багатьох років. Який із нижченаведених процесів найімовірніше відбувається в ендометрії безпосередньо перед початком менструації?

- А. Казеозний некроз
- В. Атрофія
- С. Апоптоз
- Д. Некроптоз
- Е. Фібриноїдний некроз

59. Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років, який багато років курих, спостерігається виражений сегментарний склероз стінки правої стегнової артерії зі звуженням її просвіту та розповсюдженням на оточуючі тканини. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хвороба Бюргера-Вінівартера
- В. Вузликовий артеріїт
- С. Хвороба Мондора
- Д. Медіосклероз Менкеберга
- Е. Синдром Рейно

60. Під час гістологічного дослідження біоптата печінки (забарвлення гістологічних зрізів гематоксином і еозином) в пацієнта з гострим захворюванням печінки виявлено: окремі чітко обмежені рожеві об'єкти гомогенної структури овальної та круглої форми, діаметром близько 15-25 мкм, з невеликими фрагментами гематоксинофільного матеріалу всередині або без нього (тіля Каунсілмена). Для якого загальнопатологічного процесу характерні виявлені зміни?

- А. Гідропічної дистрофії
- В. Апоптозу
- С. Гіалінозу
- Д. Некрозу
- Е. Гіаліново-краплинної дистрофії

61. У чоловіка спостерігається збільшення розмірів носа, губ, вух, нижньої щелепи, а також кистей та стоп. Під час обстеження виявлено аденокарциному гіпофіза. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- А. Цукровий діабет
- В. Хвороба Педжета
- С. Акромегалія
- Д. Гіпофізарний нанізм
- Е. Аутоімунний тиреоїдит

62. Під час розтину тіла чоловіка, який довгий час зловживав алкоголем,

встановлено, що печінка зменшена в розмірах, поверхня її бугриста. Гістологічно: часточкова будова печінки різко порушена, інтенсивний фіброз, наявність псевдочасточок. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алкогольний гепатит
- B. Рак печінки
- C. Токсична дистрофія печінки
- D. Жирова дистрофія печінки
- E. Цироз печінки

63. У восьмирічної дитини з правої стегнової кістки взяли трепанобіоптат. Під час його мікроскопічного дослідження майже не виявлено нормальної кісткової тканини, а переважно фіброзна тканина з різнонаправленими пучками колагенових волокон та фібробласти й кровоносними судинами. Переламів кісток в анамнезі немає. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Остеомієліт
- B. Остеопетроз
- C. Остеогенна саркома
- D. Остеопороз
- E. Фіброзна остеодисплазія

64. Хлопчик помер у віці 14 років. З анамнезу відомо, що хворів із раннього дитинства, відбувалася прогресуюча слабкість м'язів тазового пояса, стегон, гомілок, а наприкінці хвороби - плечового пояса й тулуба. Уражень обличчя та спини не було. Під час посмертного гістологічного дослідження уражених м'язів виявлено: виражену групову атрофію слабопофарбованих м'язових волокон без ознак автоімунного процесу в інтерстиції (без підвищення кількості лімфоцитів). В атрофованих м'язових клітинах гістохімічно виявлено зменшений вміст глікогену, а поляризаційним методом — зникнення посмугованості. Відбулося розростання жирової та сполучної тканини в скелетних м'язах. Який найімовірніший діагноз?

- A. М'язова дистрофія Ерба
- B. Міотонія Томсена
- C. Міотонія Ейленбурга
- D. М'язова дистрофія Дюшена
- E. Дерматоміозит

65. Юнак віком 18 років скаржиться на виражену болючість правої нижньої кінцівки в ділянці стегна. Під час рентгенологічного дослідження нижньої кінцівки спостерігається: трикутник Кодмана та деструктивне утворення з

інфільтрованими краями. За результатами гістологічного дослідження кісткової тканини виявлено: кісткова тканина тонка, візуалізується утворення з мереживною структурою, сформоване анапластичними пухлинними клітинами, триполярні мітози. Який найімовірніший діагноз?

- A. Саркома Юїнга
- B. Остеосаркома
- C. Остеохондрома
- D. Остеобластома
- E. Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина

66. Під час патологоанатомічного розтину тіла пацієнта віком 58 років, померлого від гострої серцевої недостатності, виявлено: гострий трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця, набряк легень, гіпертонічну хворобу, загальне венозне повнокрів'я внутрішніх органів, стенозний коронарний атеросклероз, цукровий діабет II-го типу. Яким захворюванням є стенозний коронарний атеросклероз у патологоанатомічному діагнозі?

- A. Конкурентним
- B. Основним
- C. Фоновим
- D. Поєднаним
- E. Вторинним

67. Пацієнта віком 72 роки шпиталізовано зі скаргами на біль за грудиною, що виник раптово та іррадіював у ліву руку. Під час ЕКГ виявлено: депресія інтервалу ST та інверсія зубця T у бічних відведеннях. Під час лабораторних досліджень виявлено: загальний холестерин - 11,2 ммоль/л, ЛПНЩ - 8,1 ммоль/л, тропонін I - 3,27 нг/мл. З анамнезу відомо, що чоловік палить близько 30 років по 2 пачки на день. Що з нижченаведеного спричинило розвиток захворювання?

- A. Накопичення окиснених ЛПНЩ в судинній стінці
- B. Накопичення окиснених ЛПНЩ в макрофагах інтими
- C. Адгезія моноцитів крові до ендотелію
- D. Міграція гладком'язових клітин з медіа в інтиму
- E. Дисфункція ендотеліальних клітин

68. Під час гістологічного дослідження лімфатичного вузла пацієнта спостерігається: проліферація лімфоцитів, гістіоцитів, ретикулярних клітин,

гігантські клітини з великою кількістю ядер. Діагностовано лімфогранулематоз. Які клітини характерні для цього захворювання?

- A. Ph-хромосома
- B. Мікуліча
- C. Вірхова
- D. Рід-Березовського-Штернберга
- E. Боткіна-Гумпрехта

69. Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози пацієнтки віком 35 років виявлено: заміщення кубічного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферацію епітелію з утвореннями, що нагадують сосочки, вакуолізацію та зміну тінкторіальних властивостей колоїду, інфільтрація стромы лімфоцитами та плазмочитами, формування лімфатичних фолікулів із зародковими центрами. Який найімовірніший діагноз?

- A. Спорадичний зоб
- B. Дифузний токсичний зоб
- C. Аутоімунний тиреоїдит (зоб Гашімото)
- D. Аденокарцинома
- E. Хвороба Аддісона

70. В анамнезі в пацієнтки віком 27 років періодичне вживання високих доз ацетилсаліцилової кислоти у пігулках без оболонки через сильну мігрень. Чергове вживання аспірину викликало сильний біль в епігастральній області. Під час гастродуоденоскопії виявлено: слизова оболонка шлунку у всіх відділах вкрита густим слизом, повнокровна, набухла, поверхневих дефектів не виявлено. Біоптати слизової оболонки з різних відділів шлунку взяті зранку натще. Гістологічно виявлено: набряк і повнокров'я слизової оболонки, густа інфільтрація поліморфноядерними лейкоцитами. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- A. Гострого катарального гастриту
- B. Хронічного атрофічного гастриту
- C. Гострого ерозивного гастриту
- D. Хронічного гіпертрофічного гастриту
- E. Пептичної виразки шлунку

71. У пацієнта віком 54 роки у фіналі тривалого захворювання розвинулася виражена м'язова слабкість плечового поясу, потім спини та грудної клітки. Розумові здібності були збережені аж до смерті. Здатність самостійно пересуватися прогресивно знижувалася. Чоловік помер від зупинки дихання спінального типу. Під

час розтину виявлено: стоншення й сірий колір передніх корінців спинного мозку. Мікроскопічно спостерігається: в спинному мозку різке зменшення числа нейронів, особливо рухових нейронів передніх рогів спинного мозку. Спостерігається гліоз та руйнування мієлінових волокон передніх корінців. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- A. Хвороби Паркінсона
- B. Токсоплазмозу
- C. Хвороби Кройтцфельда-Якоба
- D. Бічного аміотрофічного склерозу
- E. Медулобластоми

72. Пацієнт віком 38 років скаржиться на погіршення слуху. З анамнезу відомо про часті інфекційні захворювання сечовивідних шляхів, значні порушення слуху та розвиток ниркової недостатності у його дядька. АТ - 150/93 мм рт. ст. У загальному аналізі сечі: макрогематурія та протеїнурія. Проведено біопсію нирки. Під час гістологічного дослідження виявлено: фокальний гломерулярний склероз, атрофія каналців, інтерстиційний фіброз. Базальна мембрана нерегулярна за товщиною, виявлено ділянки стоншення та потовщення, розшарування щільної пластинки у вигляді шахівниці при електронній мікроскопії. Який найімовірніший діагноз?

- A. Синдром Альпорта
- B. Хвороба тонкої базальної мембрани
- C. Тубулоінтерстиційний нефрит
- D. Мембранопроліферативний гломерулонефрит
- E. Мембранозна нефропатія

73. Під час патологоанатомічного розтину тіла чоловіка віком 26 років, який помер від профузної шлунково-кишкової кровотечі, виявлено: виразку дванадцятипалої кишки і свіжу кров у просвіті шлунку та тонкої кишки. В анамнезі рецидивна виразка дванадцятипалої кишки після операції селективної ваготомії. У підшлунковій залозі виявлено рожеві вузлики діаметром 0,5 см. Вкажіть основне захворювання в патологоанатомічному діагнозі.

- A. Синдром Маллорі-Вейсса
- B. Виразка дванадцятипалої кишки
- C. Синдром Золлінгера-Еллісона
- D. Дивертикул дванадцятипалої кишки
- E. Рак підшлункової залози

74. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на біль унизу живота. На основі комплексного обстеження встановлено клінічний діагноз: кістома лівого яєчника. Проведено оперативне лікування. Під час гістологічного дослідження виявлено: новоутворення складається з гнізд зрілого перехідного епітелію (уротелій), що розташовані у щільній чітко окресленій фіброматозній стромі. В окремих гніздах наявні центральні кістозні простори, які вистелені стовпчастим епітелієм та містять муцин. Мітотична активність не підвищена. Якому діагнозу відповідає така мікроскопічна картина?

- A. Пухлина Бреннера
- B. Муцинозна цистаденома
- C. Текома
- D. Фіброма
- E. Тератома

75. Жінка віком 25 років у терміні вагітності 39 тижнів народила хлопчика з ознаками внутрішньоутробної інфекції. З анамнезу відомо, що у II триместрі перенесла COVID-19 середньої тяжкості. Під час гістологічного дослідження плаценти виявлено: запальна інфільтрація у ворсинках хоріону. Укажіть патологічний стан, що розвинувся в плаценті.

- A. Вілузит
- B. Хоріонамніоніт
- C. Інтервілузит
- D. Децидуїт
- E. Фунікуліт

76. Пацієнтку віком 73 роки шпиталізовано до лікарні зі скаргами на утруднення дихання в стані спокою, нападоподібний вологий кашель. Симптоми з'явилися декілька місяців тому та поступово посилювалися. Під час обстеження виявлено: геморагічний лівобічний плеврит та перикардит. Під час ЕКГ спостерігається: інверсія зубця Т у більшості відведень, тропонін I - 0,03 нг/мл, температура тіла - 37°C. Під час рентгенологічного дослідження виявлено: затемнення у нижній долі лівої легені у вигляді малоінтенсивного інфільтрату з нечіткими контурами з поширенням на плевру. За декілька днів пацієнтка померла від наростаючої серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлено: у лівій легені визначається вогнище ущільненої консистенції без чітких меж, сіро-білого кольору, геморагічний перикардит, гіпертрофія правого та лівого шлуночка серця. Під час гістологічного

дослідження спостерігається: в легеневій тканині - вогнища залозоподібних ацинарних структур, деякі зі слизом, які вкриті епітелієм з гіперхромними поліморфними ядрами, в серці - дифузний кардіосклероз та гіпертрофія кардіоміоцитів. Якому діагнозу відповідає описана клінічна та морфологічна картина?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Плеврит
- C. Аденокарцинома легені
- D. Бронхопневмонія
- E. Хронічний бронхіт

77. Під час патологоанатомічного розтину тіла дворічної дитини виявлено: відставання в рості, низька маса тіла, гепатомегалія. В анамнезі - анорексія, гіпоглікемія, кетонемічні кризи. Під час гістологічного дослідження печінки спостерігається: гепатоцити різко збільшені з 'водянистою' цитоплазмою, під час забарвлення гістологічних препаратів печінки на глікоген - реакція різко позитивна. Яке основне захворювання встановлено на розтині?

- A. Хвороба Гірке
- B. Аутоімунний гепатит
- C. Цистиноз
- D. Хвороба Гоше
- E. Хвороба Тея-Сакса

78. Під час розтину тіла чотирирічної дитини, яка померла внаслідок асфіксії, на слизовій оболонці зів, мигдалин, надгортанника спостерігаються сірувато-білі плівки, щільно спаяні з підлеглими тканинами. Укажіть вид запалення.

- A. Катаральне
- B. Дифтеритичне
- C. Крупозне
- D. Серозне
- E. Геморагічне

79. Під час гістологічного дослідження тканини щитоподібної залози спостерігається скупчення полігональних та веретеноподібних клітин, наявність амілоїду у стромі, мультицентрична гіперплазія С-клітин у прилеглій паренхімі. Вкажіть гістологічний тип карциноми.

- A. Фолікулярна
- B. Анапластична
- C. Папілярна
- D. -
- E. Медулярна

80. Пацієнт віком 56 років помер від прогресування хронічної ниркової недостатності. В ході патологоанатомічного розтину виявлено фібринозний перикардит, двобічну гнійну бронхопневмонію, бронхоектатичну хворобу, анасарку, системний амілоїдоз, гіпертонічну хворобу, аденому правої нирки, набряк легень. Вкажіть, з якого захворювання потрібно почати формулювання патологоанатомічного діагнозу.

- A. Бронхоектатична хвороба**
- B. Фібринозний перикардит**
- C. Системний амілоїдоз**
- D. Гіпертонічна хвороба**
- E. Аденома правої нирки**

81. Пацієнтці, яка хворіє на безпліддя, проведено сальпінгоофоректомію. Макроскопічно спостерігається: яєчники збільшені, сіро-білого кольору, із гладенькою корою та численними кістами. Під час гістологічного дослідження виявлено: стовщена фіброзна капсула, що вкриває кістозні фолікули, вистелені гранульозними клітинами із гіперпластичною лютеїновою внутрішньою оболонкою, жовтих тіл немає. Для якого патологічного стану характерні ці морфологічні зміни?

- A. Зрілої кістозної тератоми**
- B. Муцинозної цистаденоми**
- C. Синдрому полікістозних яєчників**
- D. Незрілої кістозної тератоми**
- E. Хоріокарциноми**

82. Під час розтину тіла чоловіка віком 43 роки, який багато років зловживав алкоголем, встановлено патологоанатомічний діагноз: алкогольний гепатит. Поява яких мікроскопічних змін характерна для цього захворювання?

- A. Клітин Іто**
- B. Клітин Вірхова**
- C. Тілець Русселя**
- D. Тілець Каунсільмена**
- E. Тілець Маллорі**

83. У пацієнтки об'єктивно спостерігається: ожиріння, артеріальна гіпертензія, тривала гіперглікемія. Смерть настала внаслідок крововиливу в головний мозок. Морфологічне дослідження виявило базофільну аденому гіпофіза, вузлову гіперплазію кори надниркових залоз. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Синдром Іценко-Кушинга**
- B. Хвороба Грейвса**
- C. Цукровий діабет**
- D. Акромегалія**
- E. Гіпофізарний нанізм**

84. У чоловіка віком 32 роки, який хворів на гнійний отит, раптово погіршився стан: пацієнт став дезорієнтованим, апатичним, з'явилися ригідність потиличних м'язів і підвищення температури тіла до 39,5°C) Через 5 годин настала смерть. Результати патологоанатомічного розтину підтвердили клінічні дані. Яку безпосередню причину смерті встановлено під час розтину?

- A. Медіастиніт**
- B. Септицемія**
- C. Міокардит**
- D. Менінгіт**
- E. Мастоїдит**

85. У жінки віком 38 років під час патологоанатомічного розтину в пілоричному відділі шлунка по його малій кривизні виявлено дефект стінки круглястої форми діаметром 1,8 см. Під час тонкого препарування в глибині дефекту виявлено тканину печінково-дуоденальної зв'язки, яка міцно з'єдналася зі стінкою шлунка в місці дефекту. Для якого ускладнення хвороби шлунка це характерно?

- A. Пенетрації**
- B. Перидуоденіту**
- C. Перигастриту**
- D. Перфорації**
- E. Стенозування**

86. Під час гістологічного дослідження легеневої тканини пацієнта виявляються множинні гнійні вогнища. Ексудат, збагачений нейтрофілами, заповнює бронхи та бронхіоли та визначається здебільшого в просвітах прилеглих альвеол. Є ділянки легеневої тканини вільні від гнійного ексудату. Для якого захворювання легень характерна така гістологічна картина?

- A. Лобарної пневмонії**
- B. Лобулярної пневмонії**
- C. Інтерстиціального пневмоніту**
- D. Легеневого абсцесу**
- E. Бронхоектатичної хвороби**

87. Під час патологоанатомічного розтину тіла чоловіка віком 32 роки, шпиталізованого зі скаргами на загальну

слабкість, лихоманку, кашель із виділенням крові та значне схуднення, який помер від прогресування дихальної недостатності, було встановлено захворювання, яке є однією з провідних причин смертності від інфекційних та паразитарних захворювань серед осіб працездатного віку. Під час гістологічного дослідження осередків ураження легень виявлено: гранулематозне запалення із казеозним некрозом у гранульомах. Яке захворювання спричинило виникнення симптомів у пацієнта?

- A. Мікоз
- B. Вірусна пневмонія
- C. Скарлатина
- D. **Туберкульоз**
- E. Дифтерія

88. Під час розтину тіла жінки віком 45 років, яка померла від гострої серцевої недостатності, виявлено: серце збільшене в розмірах, товщина міокарду лівого шлуночка - 20 мм, правого шлуночка - 5 мм, трабекули та сосочкові м'язи потовщені. Які патологічні зміни виникли у серці пацієнтки?

- A. Дилатація лівого шлуночка
- B. Гіпертрофія міжшлуночкової перетинки
- C. Гіпертрофія правого шлуночка
- D. Гіпертрофія правого передсердя
- E. **Гіпертрофія лівого шлуночка**

89. Хлопчик, який народився в терміні гестації 26 тижнів шляхом екстреного кесаревого розтину, оскільки у матері була важка прееклампсія, помер через 1 добу від наростаючої респіраторної недостатності. Під час гістологічного дослідження тканини легень виявлено: чергування вогнищ ателектазу і розширених альвеол, еозинофільні гіалінові мембрани, що вистилають розширені альвеоли. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Синдром раптової дитячої смерті
- B. **Респіраторний дистрес-синдром новонароджених**
- C. Гемолітична хвороба новонароджених
- D. Водянка плода
- E. Вроджена пневмонія

90. У чоловіка віком 38 років, який хворів на атрофічний гастрит, у гіперплазованому кістковому мозку виявлено: незрілі форми еритропоезу з переважанням мегакаріобластів. Який вид анемії виник у чоловіка?

- A. Гемолітична
- B. Залізодефіцитна
- C. Гостра постгеморагічна
- D. Хронічна постгеморагічна
- E. **Вітамін В₁₂-дефіцитна**

91. Під час патологоанатомічного розтину тіла жінки віком 60 років, яка тривалий час хворіла на гіпертонічну хворобу і померла після гіпертонічного кризу, було встановлено діагноз: аневризма черевної аорти, внутрішньомозковий крововилив, дифузний міокардит, остеоартрит колінних суглобів, екстрагенітальний ендометріоз. Яке основне захворювання встановлено під час розтину?

- A. Аневризма черевної аорти
- B. Екстрагенітальний ендометріоз
- C. Гіпертонічна хвороба
- D. **Внутрішньомозковий крововилив**
- E. Дифузний міокардит

92. Пацієнту віком 55 років проведено операцію резекції шлунку через ускладнену кровотечею виразку в ділянці малої кривизни. Через 2 доби, у зв'язку з ранньою неспроможністю швів гастроентероанастомозу, у чоловіка розвинувся розлитий гнійний перитоніт, який спричинив смерть пацієнта. Під час дослідження операційного матеріалу в ділянці малої кривизни шлунку виявлено: хронічна виразка діаметром 2 см, в дні виразки - арозована велика судина. За життя пацієнт хворів хронічним обструктивним бронхітом, ускладненим емфіземою легень і дифузним пневмосклерозом. Вкажіть правильне формулювання основного захворювання в патологоанатомічному діагнозі.

- A. **Раннє розходження швів гастроентероанастомоза через 2 доби після операції резекції шлунку з кровотечею**
- B. Хронічний обструктивний бронхіт, дифузний пневмосклероз, емфізема легень
- C. -
- D. Виразкова хвороба шлунку: хронічна ускладнена кровотечею виразка шлунку (діаметр 2 см) в ділянці малої кривизни
- E. Виразкова хвороба шлунку: хронічна виразка в ділянці малої кривизни шлунку з перфорацією, розлитий гнійний перитоніт

93. Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на рідкі, кров'янисті випорожнення. Під час ректороманоскопії виявлено: набряк та гіперемія слизової оболонки, що простягається від прямої кишки до середини низхідної кишки. Під час біопсії прямої кишки виявлено: запалення слизової оболонки з абсцесами крипт, гранулоцитарні інфільтрати та метаплазія епітелію. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- A. Хвороби Крона
- B. Аденокарциноми
- C. Дивертикулу ободової кишки
- D. Виразкового коліту
- E. Псевдомембранозного коліту

94. У пацієнта тривалий час спостерігається гіперглікемія та поліурія. В анамнезі: хронічний панкреатит. Останнім часом з'явилися клінічні ознаки ниркової недостатності. Під час дослідження пункційного біоптату нирки, забарвленого гематоксиліном і еозином, лікар-патологоанатом обов'язково має знайти беззаперечну морфологічну ознаку захворювання, що спричинило підвищення рівня глюкози в крові. Вкажіть цю ознаку.

- A. Вузловий склероз ниркових клубочків
- B. Дифузний склероз ниркових клубочків
- C. Запалення інтерстицію навколо ниркової миски
- D. Гіпертрофія окремих ниркових клубочків
- E. Некроз епітелію звивистих каналців

95. Під час гістологічного дослідження шийного лімфатичного вузла у чоловіка з генералізованою лімфаденопатією виявлено проліферацію дрібних лімфоїдних клітин, які формують вузликовий малюнок, у лімфатичному вузлі відсутні центри проліферації. У кістковому мозку спостерігаються інфільтрати з подібних дрібних лімфоїдних клітин. Для якого типу лімфоми характерні ці результати гістологічного дослідження?

- A. Годжкіна
- B. Фолікулярної
- C. Дифузної В-великоклітинної
- D. Беркітта
- E. Мантійноклітинної

96. Пацієнт віком 45 років скаржиться на прогресуючу слабкість проксимальних м'язів, більше ніж дистальних, щільне пухлиноподібне утворення під кутом лівої

щелепи зліва, почервоніння шкіри обличчя. За результатами біопсії м'яза виявлено: численні інфільтрати із мононуклеарних клітин та плазмоцитів навколо судин, тубулоретикулярні вклучення в ендотеліальних клітинах, ураження м'язових волокон у перифасцикулярних та парасептальних ділянках. Який найімовірніший діагноз?

- A. Поліміозит
- B. Недиференційована плеоморфна саркома
- C. М'язова дистрофія Дюшена
- D. Міотонія
- E. Дерматоміозит

97. Пацієнт віком 62 роки, який тривалий час перебував у медичному закладі з клінічним діагнозом: системний саркоїдоз, помер від прогресивної дихальної недостатності. На патологоанатомічному розтині виявлено гіпертонічну хворобу, множинні тромбози дрібних судин, гранулематоз із поліангіїтом, шлункову кровотечу та цироз печінки. Вкажіть основне захворювання в патологоанатомічному діагнозі.

- A. Гіпертонічна хвороба
- B. Шлункова кровотеча
- C. Цироз печінки
- D. Множинні тромбози
- E. Гранулематоз із поліангіїтом

98. Під час гістологічного дослідження біоптату збільшеного лімфатичного вузла спостерігається вогнищева гіперплазія тканини за типом гранульоми, в якій зустрічаються гігантські клітини із великим багаточастковим ядром, рельєфними ядерцями з еозинофільною цитоплазмою, ділянки некрозу та склерозу. Для якого типу лімфоми характерні ці результати гістологічного дослідження?

- A. Годжкіна
- B. Беркітта
- C. Фолікулярної
- D. Мантійноклітинної
- E. Лімфоплазмочитарної

99. У пацієнта віком 43 роки на шкірі виявлено перламутрове сосочкове утворення з гладкою поверхнею і телеангіектазією. Під час гістологічного дослідження цього утворення виявлено: острівці базалоїдних клітин, що інфільтрують фіброзний позаклітинний матрикс. Пухлинні клітини із незначною кількістю цитоплазми та невеликими

гіперхромними ядрами, що в зовнішньому шарі мають палисадний тип розміщення. Для якого захворювання характерні ці результати гістологічного дослідження?

- A. Плоскоклітинної карциноми
- B. Папіломи
- C. Базальноклітинної карциноми
- D. Аденокарциноми
- E. Меланоми

100. Під час розтину тіла жінки віком 69 років виявлено: ознаки хронічного венозного застою печінки та селезінки, пастозність м'яких тканин нижніх кінцівок. Рідина в плевральних порожнинах відсутня. Вкажіть джерело розвитку перелічених патологічних змін.

- A. Системна артеріальна гіпертензія
- B. Гіпертрофічна кардіоміопатія
- C. Атеросклероз коронарних артерій
- D. Кальциноз аортального клапана
- E. Поширений легеневий фіброз

101. Під час гінекологічного огляду трирічної дівчинки в ділянці піхви виявлено об'ємне поліпоподібне утворення у вигляді винограду. Гістологічно утворення складається з клітин різної форми від круглястих до еозинофільних із поперечною посмугованістю. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лейоміосаркома
- B. Ембріональна рабдоміосаркома
- C. Лейоміома
- D. Фіброма
- E. Недиференційована плеоморфна саркома

102. Під час розтину тіла чоловіка, який тривалий час хворів на калькульозний холангіт, виявлено збільшену щільну печінку з дрібнозернистою поверхнею зеленого кольору. Під час мікроскопічного дослідження виявлено: розростання сполучної тканини, розширення жовчних капілярів і некроз периферичних гепатоцитів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Постнекротичний цироз
- B. Хронічний гепатит
- C. Прогресуючий масивний гепатонекроз
- D. Вторинний біліарний цироз
- E. Портальний цироз

103. Під час гістологічного дослідження органів дихальної та репродуктивної систем жінки віком 40 років, яка померла від тяжкої форми COVID-19, були виявлені

множинні дрібні осередки, в центрі яких спостерігаються гомогенні безструктурні еозинофільні маси. Навколо цих мас спостерігаються скупчення епітеліоїдних і гігантських багатоядерних клітин, макрофагів і лімфоцитів. Для якої структури жіночої репродуктивної системи характерні ці морфологічні особливості?

- A. Цервікального каналу
- B. Параметрія
- C. Яєчників
- D. Ендометрія
- E. Маткових труб

104. Пацієнтка віком 67 років, яка перебувала у медичному закладі з клінічним діагнозом: ішемічний коліт - померла на 7-му добу після шпиталізації. За результатами патологоанатомічного розтину вставлено основний діагноз: рак сліпої кишки з множинними метастазами у регіонарні лімфатичні вузли та внутрішні органи. Укажіть результат порівняння клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

- A. Розбіжність I категорії
- B. Розбіжність II категорії
- C. Немає розбіжності
- D. Розбіжність III категорії
- E. -

105. У пацієнта віком 38 років з'явилася олігурія, а згодом анурія. Чоловік помер. На розтині кіркова речовина обох нирок підкреслено бліда. Під час гістологічного дослідження в багатьох клітинах епітелію звивистих каналців виявлено: клітинні ядра помітно зменшені в розмірах, виглядають ущільненими з гомогенним і сильним профарбуванням каріоплазми гематоксиліном. Цитоплазма цих клітин часто фрагментована, різного кольору. Яку патологію клітинних ядер епітелію звивистих каналців нирки виявлено?

- A. Каріопікноз
- B. Каріолізис
- C. Каріорексис
- D. Набухання ядер
- E. Маргінація хроматину

106. Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на пекучий біль в епігастральній ділянці після вживання їжі, що турбує її протягом останнього року. Під час ендоскопічного дослідження виявлено: гіперемія слизової оболонки нижнього відділу стравоходу. За результатами біопсії спостерігається: базальна гіперплазія

плоского епітелію, подовження сосочків власної пластинки слизової оболонки та розсіяні інтраепітеліальні нейтрофіли з невеликою кількістю еозинофілів. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- A. Варикозного розширення вен стравоходу
- B. Стравоходу Баретта
- C. Аденокарцинома стравоходу
- D. Рефлюкс-езофагіту
- E. Стриктурни нижньої частини стравоходу

107. Під час пункційної біопсії печінки в замороженому гістологічному зрізі, який пофарбували суданом-III, у гепатоцитах виявлено: краплі різних розмірів, пофарбованих у помаранчевий колір. Ядра цих гепатоцитів збережені, нормальної будови, розташовуються або по центру гепатоцитів, або іноді по периферії. Який вид мікроскопічної патології виявлено в гепатоцитах?

- A. Жирова паренхіматозна дистрофія
- B. Апоптотичні зміни
- C. Жировий некроз
- D. Гіаліново-краплинна дистрофія
- E. Гідропічна дистрофія

108. Під час патологоанатомічного розтину тіла п'ятнадцятирічного юнака виявлено збільшення обох легень. У легеневій паренхімі присутні множинні осередкові крововиливи з буро-коричневими ущільненнями. В анамнезі: рецидивні кровохаркання. Інші внутрішні органи характеризуються малокрів'ям. Яке основне захворювання встановлено під час розтину?

- A. Геморагічний альвеоліт
- B. Синдром Гудпасчера
- C. Вторинний гемосидероз легень
- D. Первинна легенева гіпертензія
- E. Ідіопатичний гемосидероз легень

109. Пацієнту віком 42 роки проведено операцію лівобічна нефректомія через рак верхнього полюса лівої нирки (T1N0M0). У процесі оперативного втручання хірургом здійснений випадковий поріз судин лівої ниркової ніжки, що призвело до розвитку шокowego стану та спричинило смерть пацієнта. Під час гістологічного дослідження тканини пухлини виявлено: цитопlasma клітин оптично порожня, ядра невеликих розмірів, гіперхромні. Вкажіть правильне формулювання основного

захворювання в патологоанатомічному діагнозі.

- A. Гостра постгеморагічна анемія, рідка кров у порожнинах серця, просвіті великих судин, точкові крововиливи в плевру і перикард, 'шокові нирки'
- B. Інтраопераційна кровотеча з пошкоджених судин ниркової ніжки в ході операції нефректомії
- C. Геморагічний шок, рідка кров у порожнинах серця, просвіті великих судин, точкові крововиливи в плевру і перикард, 'шокові нирки'
- D. Рак лівої нирки (гістологічно - нирково-клітинний) в ділянці верхнього полюса (T1N0M0). Операція лівобічної нефректомії
- E. -

110. Під час патологоанатомічного розтину тіла чотирирічної дитини виявлено: кахексія, ущільнена підшлункова залоза з фіброзними прошарками та дрібними ретенційними кістами, збільшені лімфатичні вузли брижі, у просвіті бронхів виявлено в'язкий слизово-гнійний вміст, у легенях - ознаки двобічної гнійної бронхопневмонії. Яке основне захворювання встановлено під час розтину?

- A. Хвороба Гірке
- B. Хвороба Тея-Сакса
- C. Хвороба Крона
- D. Хвороба Уіппла
- E. Муковісцидоз

111. У пацієнта раптово зросла температура тіла до 38 °C, на другу добу він помер за ознак гостро наростаючої дихальної недостатності зі сатурацією киснем 38-54% (кілька вимірювань). На розтині обидві легені рівномірно різко повнокровні, набряклі, на вигляд збільшених розмірів та ваги. На яку мікроскопічну особливість потрібно звернути увагу під час гістопатологічного дослідження?

- A. Фіброз по типу 'карніфікації'
- B. Гіаліноз стінок артеріол по типу 'воскових свічок'
- C. Фіброз в стінках респіраторних відділів по типу 'медових стільників'
- D. Фібринозна 'сітка' в просвітах респіраторних відділів
- E. Гіалінові мембрани в стінках респіраторних відділів

112. У пацієнта віком 45 років протягом 3 днів спостерігається: температура тіла - 38,5°C, утруднене дихання, кашель із виділенням мокротиння. У нижніх відділах легень вислуховуються дифузні хрипи. Під час рентгенографії грудної клітки виявлено: правобічний плевральний випіт. Під час проведення правобічного торакоцентезу отримано 300 мл рідини в'язкої консистенції, жовто-зеленого кольору, кількість лейкоцитів у рідині - 16 500 на мкл, 98% з яких складають нейтрофіли. Який із нижченаведених видів запалення найкраще описує його плевральний вміст?

- A. Фібринозне
- B. Гнилісне
- C. Катаральне
- D. Серозне
- E. **Гнійне**

113. Пацієнту віком 35 років зі скаргами на периорбітальний набряк та набряклість у ділянці гомілковостопних суглобів проведено планову біопсію нирки. Під час гістологічного дослідження зразка виявлено: численні субепітеліальні щільні відкладення, потовщення гломерулярної базальної мембрани, згладжування відростків подоцитів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Мембранопроліферативний гломерулонефрит
- B. -
- C. **Мембранозна нефропатія**
- D. Вогнищевий сегментарний гломерулосклероз
- E. Постстрептококовий гломерулонефрит

114. Пацієнтці в ургентному порядку проведено сальпінгофоректомію. На розрізі яєчника виявлено кістозне утворення, яке заповнене сальним секретом та тьмяним волоссям. Під час гістологічного дослідження спостерігається фіброзна сполучна тканина, що чергується ділянками добре диференційованого зрілого багатошарового плоского, кишкового та респіраторного типів епітелію, які формують органоїдні структури. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- A. Незрілої кістозної тератоми
- B. Муцинозної цистаденоми
- C. **Зрілої кістозної тератоми**
- D. Серозної цистаденоми

E. Хоріокарциноми

115. В анамнезі у чоловіка віком 63 роки - тривале паління цигарок та багаторічне мешкання неподалік від підприємства зі шкідливими викидами в атмосферу (діоксид сірки, діоксид азоту, формальдегід). Відомо, що тривалий час у нього були ознаки задухи, кашель та тяжке відхаркування густого слизу. Чоловік помер при явищах правошлуночкової недостатності серця. Під час розтину виявлено: бронхи нерівномірно розширені, забиті густим слизом, стінка помітно ущільнена. Під час мікроскопічного дослідження стінки бронха виявлено: епітелій з ознаками метаплазії в келихоподібні клітини, фіброз всіх шарів, нерівномірна інфільтрація лімфоцитами, плазматичними клітинами. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Хронічний бронхіт**
- B. Бронхопневмонія
- C. Гострий бронхіт
- D. Емфізема легень
- E. Пневмоконіоз

116. Пацієнту віком 50 років через хронічну виразку шлунку проведено діагностичну гастрофіброскопію. Під час проведення гастрофіброскопії випадково перфоровано стравохід. Це призвело до розвитку гнійного медіастиніта і загибелі пацієнта на 5-ту добу після діагностичної маніпуляції. Вкажіть правильне формулювання основного захворювання в патологоанатомічному діагнозі.

- A. Гнійний медіастиніт
- B. -
- C. **Перфорація стінки стравоходу під час діагностичної гастрофіброскопії**
- D. Випадкова перфорація органу під час проведення ендоскопічного дослідження
- E. Хронічна виразкова хвороба шлунку

117. До лікарні звернулася жінка віком 30 років зі скаргами на тривожність, втрату ваги на 7 кг, незважаючи на підвищений апетит, збільшене потовиділення, періодичну діарею та біль в нижній частині живота, слабкість. Під час обстеження виявлено: температура тіла – 36,9°C, пульс - 115/хв, АТ - 110/79 мм рт. ст. Під час УЗД внутрішніх органів виявлено утворення правого яєчника, лабораторно визначено незначне підвищення рівня СА-125. Була виконана правобічна оваріоектомія. Макроскопічно спостерігається: пухлина

правого яєчника розміром 4,0 см, на розрізі коричневого кольору, переважно солідної будови з дрібними кістами, заповненими желеподібною прозорою зеленуватою масою, визначаються прошарки щільної фіброзної тканини білого кольору. Мікроскопічно утворення побудоване з фолікулів нормального розміру з домішкою макро- та мікрофолікулів різного розміру з еозинофільним колоїдом. Ядра клітин мономорфні, гіперхромні, базально розташовані, строма фіброзна. Якому діагнозу відповідають результати морфологічного дослідження?

- A. Зоб яєчника
- B. Ендоетріодна карцинома
- C. Пухлина Бреннера
- D. Дермоїдна кіста
- E. Муциозна аденома

118. Пацієнтка віком 32 роки була шпиталізована з підозрою на новоутворення в ділянці підшлункової залози. Виконано біопсію новоутворення. Назвіть ключове завдання лікаря-патологоанатома під час дослідження біоптату.

- A. Аналіз морфологічних змін
- B. Оцінка фізіологічних показників
- C. Оцінка зовнішніх факторів
- D. Вивчення мікрофлори тканин
- E. Визначення хімічного складу

119. Пацієнтка віком 60 років померла від повторного геморагічного інсульту. На патологоанатомічному розтині тіла було виявлено: гіпертрофію міокарда із дифузним кардіосклерозом лівого шлуночка (товщина стінки - 1,8 см), дифузний кардіосклероз, двобічний нефросклероз, 'іржаву кісту' головного мозку, хронічний панкреатит, двобічну гнійну бронхопневмонію, набряк головного мозку. Яке супутнє захворювання повинен встановити лікар-патологоанатом у структурі патологоанатомічного діагнозу?

- A. Гіпертонічна хвороба
- B. Дифузний кардіосклероз
- C. Двобічна бронхопневмонія
- D. Хронічний панкреатит
- E. Двобічний нефросклероз

120. Чоловік помер внаслідок хронічної ниркової недостатності. Під час гістологічного дослідження тканини прищитоподібної залози спостерігається надмірна кількість 'прозорих' клітин,

розміщених у вигляді вузлів. Кількість жирових клітин зменшена. Яка ендокринна патологія є ускладненням хронічної ниркової недостатності?

- A. Лактотропна аденома гіпофіза
- B. Вторинний гіперпаратиреоз
- C. Атрофія надниркових залоз
- D. Кортикотропна аденома гіпофіза
- E. Багатовузловий зоб

121. Під час розтину тіла чоловіка, який тривалий час хворів та помер від хронічного запального захворювання легень, на розрізі легеневої тканини спостерігається: порожнина з нерівномірно потовщеними та деформованими стінками, що заповнена незначною кількістю гнійного ексудату та складається з грануляційної мембрани, грубої волокнистої сполучної тканини, що прилягає до ущільненої паренхіми легень. Для якого захворювання характерний цей результат дослідження?

- A. Емпієми плеври
- B. Бронхоектазії
- C. Первинного абсцесу легені
- D. Хронічного абсцесу легені
- E. Гангрени легені

122. Під час гістологічного дослідження біоптата лімфатичного вузла пацієнта виявлено, що він складається з численних пухлинних вузликів різної форми та розмірів, оточених шарами фіброзної тканини. У пухлинних вузликах у приблизно однакових пропорціях спостерігається: багатоядерні клітини Рід-Штернберга, одноклітинні великі клітини Годжкіна, лімфоцити, плазматичні клітини, еозинофільні гранулоцити. Укажіть гістологічну форму лімфоми Годжкіна.

- A. Пострадіаційні зміни пухлини
- B. Варіант з виснаженням лімфоцитів
- C. Нодулярний склероз
- D. Змішаноклітинний варіант
- E. Варіант з переважанням лімфоцитів

123. Пацієнтка віком 29 років потрапила в ДТП, отримала травму живота з невеликим розривом печінки. Через пів року лікування, вона почувала себе добре, на обстеженні патологічних змін внутрішніх органів не виявлено. Які гістологічні зміни тканини можна виявити під час біопсії печінки в ділянці попереднього пошкодження?

- A. Вогнищевий ангіоматоз

- В. Вогнищевий фіброз
- С. Скупчення гемосидерофагів
- Д. Скупчення нейтрофілів
- Е. Поширений фіброз

124. Під час розтину тіла чоловіка, який помер від гострої печінкової недостатності, виявлено набряклу, червоно-фіолетового кольору печінку з напруженою капсулою. Під час гістологічного дослідження спостерігається: уражена паренхіма повнокровна, із вогнищами некрозу у центральних відділах печінкових часточок, центрлобулярним фіброзом, тромбозом великих вен. Вкажіть гістологічний діагноз.

- А. Цироз
- В. Вено-оклюзійна хвороба
- С. Гепатоцелюлярна карцинома
- Д. Синдром Бадда-Кіарі
- Е. Хронічний гепатит

125. Під час аутопсії тіла чоловіка віком 40 років виявлено: щільний вузол на внутрішній поверхні твердої оболонки головного мозку. Мікроскопічно: ендотеліоподібні клітини, що тісно прилягають одна до однієї. Для якого захворювання головного мозку це характерно?

- А. Менінгіоми
- В. -
- С. Гліобластоми
- Д. Медулобластоми
- Е. Нейробластоми

126. Дівчина віком 16 років на уроці фізичної культури раптово втратила свідомість. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги діагностувала фібриляцію шлуночків серця та провела реанімаційні заходи, проте дівчина померла. З анамнезу відомо, що в родині спостерігалися випадки раптової смерті. Під час розтину тіла виявлено стовщення передньої стулки мітрального клапана, асиметричну гіпертрофію міокарда лівого шлуночка. Які гістологічні зміни в серці спостерігатимуться у цьому разі?

- А. Інтерстиціальний дифузний фіброз ендоміокарда
- В. Інтерстиціальний вогнищевий фіброз ендоміокарда
- С. Стоншення, хаотичне розташування кардіоміоцитів
- Д. Гіпертрофія, хаотичне розташування кардіоміоцитів

- Е. Заміщення кардіоміоцитів жировою тканиною

127. Під час розтину тіла жінки віком 46 років у лівій нирці виявлено кілька рубців, які деформували нирку й особливо помітно - ниркову миску та ниркові чашечки. У різних відділах нирки різних розмірів (від 0,2 см до 1,4 см) порожнини (кількістю понад 20), які заповнені густим каламутним вмістом, приблизно половина з цих порожнин мали ущільнену сіру капсулу. Мікроскопічно в стромі нирки, переважно в мозковій речовині, виявлено інфільтрати з поліморфноядерних лейкоцитів та інфільтрати з лімфоїдних клітин з явищами фіброзу. Багато каналців з атрофією епітелію і відповідно до цього - картиною 'тиреодизації' нирки. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- А. Хронічного пієлонефриту
- В. Діабетичного нефросклерозу
- С. Аспіринового інтерстиційного нефриту
- Д. Хронічного гломерулонефриту
- Е. Полікістозу нирок

128. У пацієнта віком 20 років під час патоморфологічного дослідження біоптату правого яєчка виявлено пухлину з наявністю тілець Шиллера-Дюваля. Якому діагнозу відповідає описана гістологічна картина?

- А. Тератома
- В. Сперматоцитوما
- С. Пухлина жовткового мішка
- Д. Хоріокарцинома
- Е. Семінома

129. Пацієнтку віком 36 років шпиталізовано з приводу раптового головного болю та двоїння в очах. У наступні кілька днів у неї з'явилися сильна спрага, часте сечовипускання, нудота, блювання. На другий день шпиталізації вона раптово померла. Виконано розтин тіла. Що з наведеного виявить лікар-патологоанатом на розтині?

- А. Neisseria meningitidis
- В. Субарахноїдальний крововилив
- С. Мультиформну гліобластому
- Д. Аневризму вілізівського кола
- Е. Крововилив в аденому гіпофіза

130. Який компонент активує рецепторний (зовнішній) шлях апоптозу клітин?

- А. Fas-ліганд

- B. p53
- C. BCL-2
- D. Цитохром C
- E. Актин

131. Який тип загибелі клітини включає співіснування запалення та апоптозу?

- A. Піроптоз
- B. Ентоз
- C. Некроптоз
- D. Аутофагія
- E. Некроз

132. У дівчини віком 23 роки після прийому ацетилсаліцилової кислоти розвинулася кропив'янка. В анамнезі: хронічний риніт. Під час огляду виявлено носові поліпи. Ризик якого захворювання можливий у цієї пацієнтки?

- A. Інтерстиціального фіброзу
- B. Хронічного бронхіту
- C. Емфіземи
- D. Легеневої гіпертензії
- E. Астми

133. Під час патологоанатомічного розтину тіла чоловіка віком 58 років, який помер після раптового погіршення стану з розвитком важких дихальних розладів і лихоманки, було встановлено діагноз: хронічний обструктивний бронхіт, двобічна полілобарна плевропневмонія, атеросклероз коронарних артерій, септична гіперплазія селезінки, осередкова емфізема легень. Яке основне захворювання встановлено під час розтину?

- A. Осередкова емфізема легень
- B. Септична гіперплазія селезінки
- C. Атеросклероз коронарних артерій
- D. Хронічний обструктивний бронхіт
- E. Двобічна плевропневмонія

134. Пацієнтці віком 45 років проведено операцію з видалення пухлини щитоподібної залози. Під час гістологічного дослідження спостерігається: пухлина побудована із мономорфних клітин, що формують малі фолікули, нагадує нормальну паренхіму щитоподібної залози. Пухлина оточена фіброзною капсулою з наявністю вогнищ інвазії. Для якого захворювання характерний цей результат гістологічного дослідження?

- A. Фолікулярної карциноми
- B. Папілярної карциноми
- C. Медулярної карциноми

- D. Анапластичної карциноми
- E. Фолікулярної аденоми

135. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на задишку, біль під час ковтання та сухий кашель. Згодом розвинулися ознаки мікседеми, прогресувало ущільнення в ділянці щитоподібної залози. Під час УЗД виявлено: значне ущільнення цієї залози, а також оточуючих її тканин. Пункційно взято кілька біоптатів з різних відділів щитоподібної залози. Мікроскопічно в біоптатах різко переважає фіброзна тканина з нерівномірно вираженим хронічним запаленням з накопиченням лімфоцитів, іноді трапляються невеликі залишки тканини атрофованої щитоподібної залози. Для якого захворювання характерні ці результати досліджень?

- A. Підгострого тиреоїдиту (де Кервена)
- B. Базедової хвороби
- C. Хронічного фіброзного тиреоїдиту (Ріделя)
- D. Ендемічного зоба
- E. Аутоімунного тиреоїдиту (Гашімото)

136. Під час гістологічного обстеження легеневої тканини чоловіка, якому проведено лобектомію, виявлено значні розростання волокнистої сполучної тканини, значне скупчення лімфоцитів. Бронхи й бронхіоли значно розширені та деформовані внаслідок фіброзу. Слизова оболонка вкрита призматичним епітелієм, базальна мембрана потовщена і гіалізована. Просвіт ділянок розширених бронхів заповнений гнійним ексудатом. Для якого захворювання характерний цей результат гістологічного дослідження?

- A. Бронхогенного абсцесу легені
- B. Бронхоектазії
- C. Пневмонії
- D. Інтерстиціальної перибронхіальної пневмонії
- E. Ателектазу

137. У пацієнтки віком 28 років на фоні температури тіла 38°C, що триває останні три доби, взятий трепанобіотат з груднини. Під час його гістологічного дослідження в кістковому мозку виявлено: численні поліморфноядерні лейкоцити з розпадом оточуючих тканин, розплавлення кісткових балок. Який діагноз необхідно поставити на основі описаної гістологічної картини?

- A. Гострий остеомієліт
- B. Остеопороз

- С. Фіброзна остеодисплазія
- D. Хронічний остеомієліт
- Е. Остеопетроз

138. У пацієнта віком 35 років під час гістологічного дослідження операційного матеріалу дрібних гілок брижових артерій діагностовано вузликовий периартеріт. Вкажіть можливі морфологічні зміни у стінках брижових артерій.

- A. Атеросклероз
- B. Ліпоїдоз
- С. Атероматоз
- D. **Склероз**
- Е. Амілоїдоз

139. Під час патологоанатомічного розтину тіла жінки віком 45 років, яка була шпиталізована за три доби до смерті, виявлено полісерозит, анасарку, системний червоний вовчак, венозне повнокрів'я печінки, ерозивну гастропатію, дистрофічні зміни внутрішніх органів. Недостатність якого органу стала безпосередньою причиною смерті?

- A. Легень
- B. Серця
- С. Печінки
- D. **Нирок**
- Е. Надниркових залоз

140. Пацієнт віком 39 років після тривалої іммобілізації раптово втратив свідомість. У нього діагностовано інфаркт головного мозку. Який із нижченаведених патологічних станів спричинив розвиток цього ускладнення?

- A. Системна тромбоемболія
- B. Жирова емболія
- С. Аневризма Беррі
- D. **Дефект міжшлуночкової перегородки**
- Е. Клиноподібний інфаркт легені

141. Під час розтину тіла чоловіка віком 70 років у верхній частці правої легені спостерігається вузлувате утворення. Під час гістологічного дослідження виявлено: у центрі - осередок некрозу, на периферії - вал з епітеліоїдних клітин, лімфоцитів, між якими наявні гігантські клітини, прояви ендovasкуліту відсутні. Для якого захворювання легень це характерно?

- A. Сифілітичної гранульоми
- B. Пневмонії Фрідлендера
- С. Риносклероми
- D. **Туберкульозної гранульоми**
- Е. Лепрозної гранульоми

142. Під час гістологічного дослідження біоптату піхвової частини шийки матки виявлено: всю товщу епітелію замінюють атипові диспластичні клітини. Ознаки диференціації клітин плоского епітелію відсутні, чітко виражений ядерний та клітинний плеоморфізм та численні фігури мітозу, що досягають поверхні епітеліального пласта. Структура базальної мембрани не порушена, у субепітеліальній стромі ріст пухлини відсутній. Для якого виду патологічного процесу характерні виявлені зміни?

- A. Аденокарциноми
- B. Плоскоклітинної карциноми G2
- С. -
- D. Плоскоклітинної карциноми G1
- Е. **Тяжкої дисплазії**

143. Під час макроскопічного дослідження спостерігається: видалена щитоподібна залоза збільшена в розмірі, щільної консистенції з інтактною капсулою. Під час гістологічного дослідження виявлено: ділянка пошкодження тиреоїдних фолікулів, наявність вільного колоїда, навколо якого знаходяться гігантоклітинні гранульоми, інфільтрація лімфоцитами, плазмочитами та макрофагами. Для якого типу тиреоїдиту характерні ці гістологічні зміни?

- A. Гашімото
- B. -
- С. Ріделя
- D. **Де Кервена**
- Е. Підгострого лімфоцитарного

144. Під час гістологічного дослідження мітрального клапана чоловіка віком 53 роки виявлено: стоншення фіброзного шару стулок, потовщення губчастого шару, відкладання мукоїдної речовини. Для якого патологічного процесу характерна така морфологічна картина?

- A. Ревматизму
- B. Хвороби Чорногубова
- С. **Міксоматозної дегенерації**
- D. Синдрому Марфана
- Е. Ендокардиту Лібмана-Сакса

145. Під час гістологічного дослідження в дистальних звивистих каналцях та збірних трубочках нирки виявлено білкові циліндри Бенса Джонса, оточені багатоядерними велетенськими клітинами. Вкажіть гістологічний діагноз.

- A. Системний червоний вовчак

- В. Лімфома Годжкіна
- С. Серпоподібноклітинна анемія
- Д. Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз
- Е. **Множинна мієлома**

146. Під час розтину тіла жінки віком 60 років, яка довгий час хворіла на цукровий діабет та хронічний пієлонефрит, встановлено: поверхня нирок з вираженою бугристістю, сосочки зморщені, темно-бурі, місцями звапнені. Який найімовірніший діагноз?

- А. **Некротичний папіліт**
- В. Хронічна ниркова недостатність
- С. Вузликовий периартеріт
- Д. Гострий кортикальний некроз
- Е. Сифілітична гранульома

147. На розтині тіла померлої дворічної дитини в мозковій речовині надниркової залози справа виявлено: вузлове утворення з нечіткими контурами діаметром близько 4,5 см. Гістологічно утворення складалося з примітивних клітин з темними ядрами, вузькою цитоплазмою, часто зустрічалися об'єкти, ідентифіковані як псевдорозетки Гомера-Райта. Який діагноз, згідно з описаною гістологічною картиною, повинен бути встановлений?

- А. **Нейробластома**
- В. Феохромоцитома
- С. Синдром Уотерхауза-Фрідеріксена
- Д. Хвороба Вільмса
- Е. Туберкульоз

148. Під час розтину тіла чоловіка віком 42 роки, який помер у зв'язку з розвитком гострої надниркової недостатності, встановлено: шкірні покриви та слизові оболонки з бронзовим відтінком, гіперплазія клітин Лангерганса, атрофія міокарда, звуження просвіту судин. Який найімовірніший діагноз?

- А. Рак наднирників
- В. Туберкульоз наднирників
- С. -
- Д. Феохромоцитома
- Е. **Хвороба Аддісона**

149. Під час пункційної біопсії нирки в багатьох клітинах епітелію звивистих каналців виявлено: внутрішньоцитоплазматичні агрегати круглястої форми різних розмірів, що інтенсивно забарвилися еозином в рожево-червоний колір. Під час застосування гістохімічної реакції на білок ці внутрішньоцитоплазматичні об'єкти

профарбувалися позитивно та інтенсивно. Клітинні ядра без помітних змін. Для якої патології характерні мікроскопічні зміни в клітинах епітелію звивистих каналців нирки?

- А. **Гіаліново-краплинної дистрофії**
- В. Гідропічної дистрофії
- С. Колікваційного некрозу
- Д. Коагуляційного некрозу
- Е. Жирової паренхіматозної дистрофії

150. Пацієнтці проведено субтотальну резекцію щитоподібної залози. Під час гістологічного дослідження виявлено: проліферація епітелію з утворенням сосочків, що гілкуються всередині фолікулів, вакуолізація колоїду та лімфоцитарна інфільтрація строми. Який патологічний процес розвинувся в щитоподібній залозі?

- А. Папілярна карцинома
- В. Ендемічний зоб
- С. Базедова хвороба
- Д. Аутоімунний тиреоїдит (Гашімото)
- Е. **Хвороба Грейвса**